ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ВРАЧЕЙ · ПАМЯТКА ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

Лактазная недостаточность

Как отличить от аллергии и подобрать смесь

Лактазная недостаточность — неспособность расщеплять лактозу. У младенцев чаще встречается вторичная (транзиторная) форма, которая разрешается по мере восстановления слизистой.

Формы

- Первичная (врождённая) — редкая, связана с генетической недостаточностью лактазы.
- Вторичная — после кишечных инфекций, при повреждении слизистой; наиболее частая у младенцев.
- Транзиторная — у недоношенных детей из-за незрелости ферментной системы.

Клиника и отличие от АБКМ

- Вздутие, колики, пенистый кислый стул, беспокойство после кормления.
- При АБКМ дополнительно — кровь в стуле, экзема, рвота, плохая прибавка веса.
- Изолированная лактазная недостаточность не вызывает кожных проявлений.

Диагностика

- Ведущий метод — клиническая оценка и провокация лактозой.
- Водородный дыхательный тест — по показаниям, у детей старше 3 месяцев.
- Не назначать «анализ на лактозу» всем детям с коликами.

Питание

- Выраженная форма — безлактозная смесь на 2–4 недели с последующим пересмотром.
- Умеренная — низколактозная смесь длительно, до нормализации стула.
- При грудном вскармливании — фермент лактаза в каплях перед кормлением, грудное молоко сохраняется.
- Не отменять грудное вскармливание при лактазной недостаточности.

Ситуация	Предпочтение
Выраженные симптомы, потеря веса	Безлактозная смесь, наблюдение 2 недели
Умеренные проявления	Низколактозная смесь длительно
Грудное вскармливание	Фермент лактаза перед кормлением

Демонстрационный материал. Текст подлежит утверждению медицинским отделом компании перед публикацией. Не является инструкцией по применению.